الفحص المفصـــلي للطرفين العلويين 2

1 د. تسنيم دريعي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

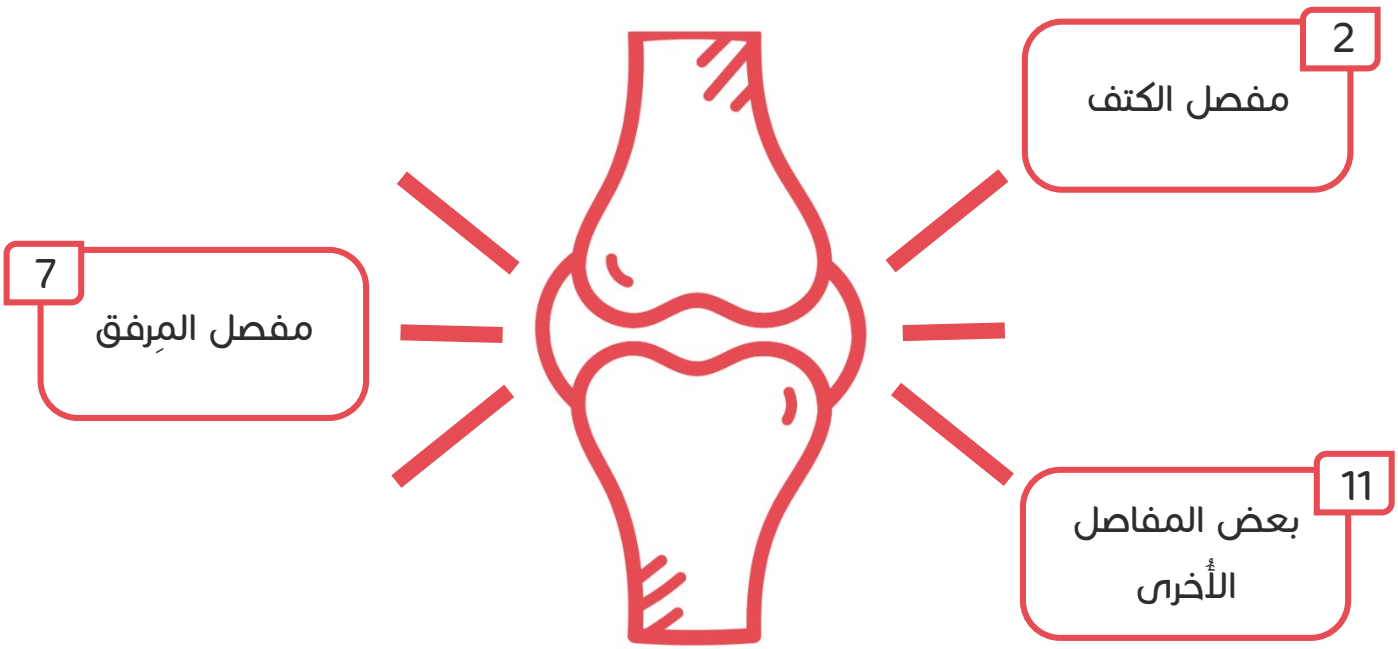
المهارات السريرية | Clinical Skills

RB Medicine

السلام عليكم

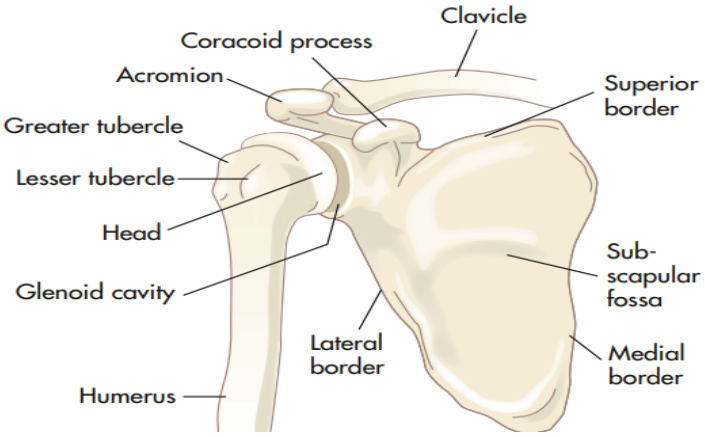
أصدقاءنا الأعزاء، نقدم لكم القسم الثاني للمحاضرة السابعة من مادة المهارات السريرية، وهي الأولى من قسم د. تسنيم، فبعد أن بدأنا الحديث في المحاضرة السابقة للدكتور مهند عن فحص مفاصل الطرفين العلويين ودرسنا مفاصل اليدين والمعصمين، نتابع اليوم مع دراسة مفصل الكتف ومفصل المرفق وبعض المفاصل الأُخرى

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل



مُقدّمة

- بعد أن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن فحص اليدين والمعصمين، سندرس اليوم فحص المفاصل الأخرى في الطرفين العلويين.
- تُسهم عدة مفاصل في حركة الكتف، وهي:
  1. المفصل الكتفي العضدي وهو **المفصل الرئيسي** (كروي وواسع الحركة جداً).
  2. المفصل الأخرمي الترقوي.
  3. المفصل القصي الترقوي.
  4. حركة لوح الكتف على جدار الصدر.



سنتحدث عن هذه المفاصل جميعها بالإضافة لمفاصل أُخرى في محاضرتنا هذه، ونبدؤها مع مفصل الكتف ..

مفصل الكتف

- يُعد مفصل الكتف **من المفاصل الزليلية**، وهو اتصال **رأس العضد** مع **الجوف الحقاني لعظم الكتف**.
- يُعتبر ألم الكتف **شائعاً**، إذ يكون عَرَضاً للعديد من الأمراض، وقد يكون واحداً من أنواع الألم الثلاثة التي درسناها:

ألم التهابي	ألم ميكانيكي	ألم رجيع
• الأمراض المناعية الذاتية كالداء الرثياني والذئبة.	• الكتف المتجمدة. • التهاب الأوتار. • التهاب الأجربة.	• ذات الرئة القاعدية. • التهاب المرارة. • احتشاء العضلة القلبية.

توجد الأجربة بين أوتار العضلات والعظم من أجل تخفيف الاحتكاك ويمكن أن تتعرض للإصابة بمختلف الحدثيات المرضية.

تعلمنا سابقاً التمييز بين الألم الميكانيكي والالتهابي، ولكن كيف نميز الألم الرجيع؟

- إذا كان الألم رجيعاً سيكون فحص الكتف **طبيعياً**، وتكون المناورة الفاصلة بفحص المدى الحركي للمفصل، فإذا **لم يتحرض الألم** أثناء الفحص **يكون الألم رجيعاً**.
- وكذلك توجد مع الألم الرجيع **بعض الأعراض المرافقة** (فمثلاً مريض احتشاء العضلة القلبية يعاني من الألم، التعرق، الغثيان، اضطراب النبض ..).
- يشير ألم الكتف **الأيسر** إلى احتشاء القلب، بينما يشير ألم الكتف **الأيمن** إلى التهاب المرارة.

فحص مفصل الكتف

❖ يكون تسلسل الفحص كالآتي:

التأمل ← الجس ← فحص الحركة

أولاً: التأمل Inspection:

☑ يكون التأمل من الأمام والخلف front and back، ويجب التأكد من:

1. **الهندسة السوية** للمفصل ومقدار ارتفاع الكتف وعظم الكتف.
2. **تناظر الكتفين** Symmetry: أي عدم وجود كتف أعلى من آخر.[1]
3. عدم وجود **ضمور في العضلات** Muscle Atrophy.
4. **التشوهات:** كالكتف المتجنحة.
5. **التورم:**

← يُعد التورم في مفصل الكتف **نادراً** ويحدث في الحالات الشديدة كونه مفصل عميق.

← **يُشاهَد في حالات:** الخلع وكسور النهاية القريبة للعضد والالتهابات المفصليّة المتقدمة والإنتان القيحي.

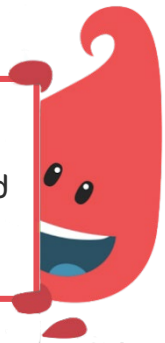
ثانياً: الجس Palpation:

☑ توجد نقاط علام أساسية يجب تحديدها وجسها أثناء الفحص وهي:

1. **الناتئ الغرابي** Coracoid process.
2. **حدبة العضد الكبرى** Greater tubercle.
3. **المفصل الأخرمي الترقوي** Acromioclavicular joint:

← إذ نجسّ الترقوة من الأمام وشوك الكتف من الخلف، فتكون **نقطة التقائهما** مكان المفصل.

والآن مع فيديو مترجم من Macleod عن فحص الكتف مدته 5 دقائق تقريباً



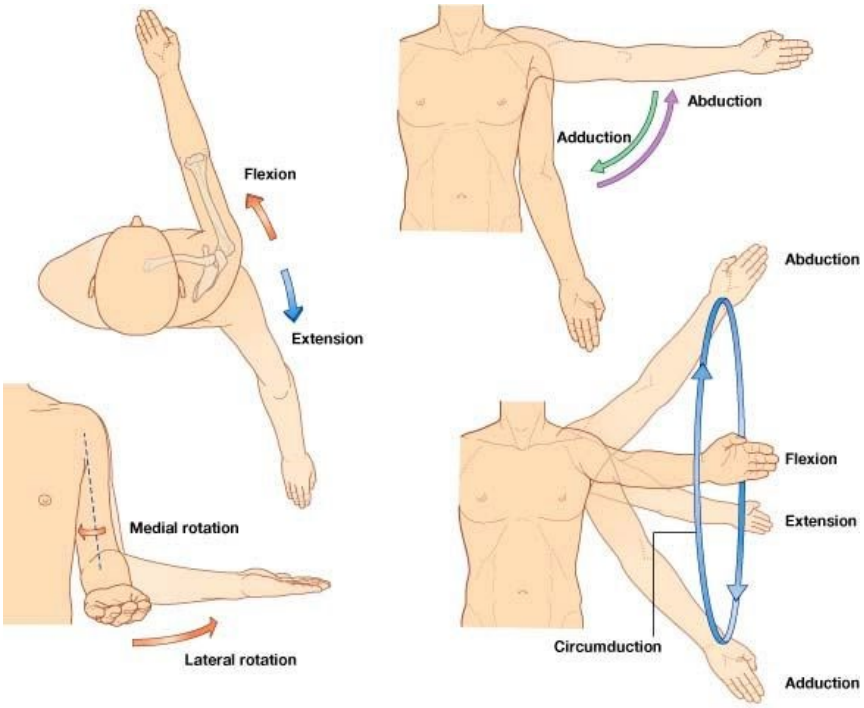
[1] **عدم التناظر** Asymmetry.

ثالثاً: فحص الحركة Movement:

☑ إنّ مفصل الكتف من المفاصل الكروية، وله حركات واسعة:

دوران وحشي	دوران إنسي
تبعيد	تقريب
عطف (180 درجة)	بسط (60 درجة)

حركات دورانية



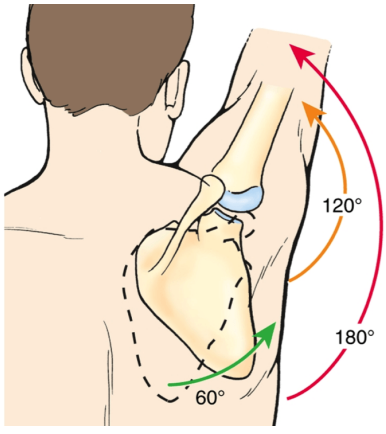
يتم الدوران الوحشي بواسطة المفصل الكتفي العضدي فقط، بينما تشترك العوامل الأربعة التي درسناها في المقدمة بالقيام بالحركات الأُخرى.

☑ توجد نقاط علام أساسية يجب تحديدها أثناء فحص حركات مفصل الكتف:

تحدد الحركة ← الألم ← الفرقعة المفصلية

↙ آلية الفحص:

- نبدأ الفحص بتحريك الكتف بدءاً من **الوضعية صفر**.
- يجب أن يقف الفاحص خلف المريض أو بمحاذاته ويمسك بذراعه بطريقة معينة بحيث تكون **أصابعه من الأمام** لتشعر بالترقوة **والابهام من الخلف** لتحسس حركة لوح الكتف على جدار الصدر، ونفحص المفصل أثناء الحركة.



ملاحظة

عندما يقوم شخص برفع ذراعه حتى 90-120 درجة لا يتحرك لوح الكتف لأن المسؤول عن هذه الحركة هو المفصل الكتفي العضدي بالذات، لكن إذا رفع ذراعه أكثر من ذلك نلاحظ تحرك لوح الكتف على جدار الصدر.

☑ تشترك عدة عضلات في عملية تبعيد الكتف (رفع الذراع)، وتختلف العضلة المسؤولة عن الحركة بحسب مدى الحركة:



☑ في حال كانت الشكاية ليست كتفية، أي زار المريض الطبيب لسببٍ آخر ولم يشكِ من وجود ألم في الكتف، يجب أن نقوم بفحص الكتف لنتأكد من سلامته (كما تعلمنا يجب على الطبيب التأكد من سلامة جميع الأجهزة).

☑ في هذه الحالة نفحص الكتف بجعل المريض يقوم بحركتين مركبتين على الشكل الآتي:

1. الحركة الأولى:

✓ نطلب من المريض وضع **راحتي اليدين خلف الرقبة**.

✓ نتحرى في هذه الحركة كلاً من:

البسط	التبعيد	الدوران الخارجي

2. الحركة الثانية:

✓ نطلب من المريض وضع **ظهري اليدين بين لوحي الكتف**.

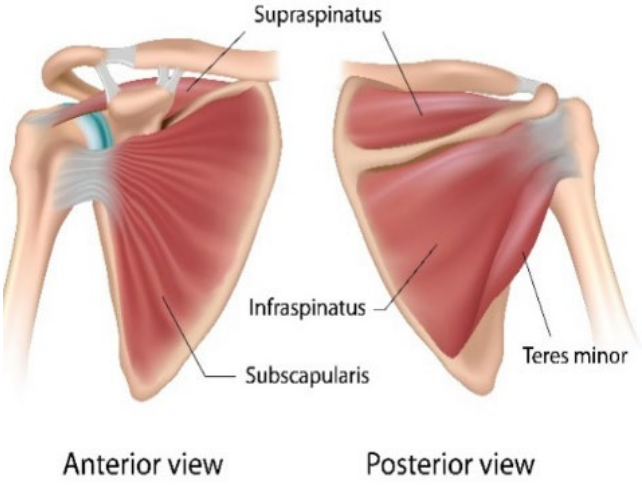
✓ نتحرى في هذه الحركة كلاً من:

العطف	التقريب	الدوران الداخلي

والآن ننتقل لدراسة إحدى الحالات المرضية الشائعة في مفصل الكتف ..

متلازمة الكفة المُدَوِّرة

↙ تذكرة: عضلات الكفة المُدَوِّرة The Rotator Cuff:



فوق الشوكية Supraspinatus	تقوم بالتبعيد (وهي العضلة **الأهم**)
تحت الشوكية Infraspinatus	تقوم بالدوران الوحشي
تحت الكتفية Subscapularis	تقوم بالدوران الإنسي
المدورة الصغيرة Teres Minor	تقوم بالدوران الوحشي

ترتكز جميع هذه العضلات على أحدوبتَي العضد.

❖ إذا التهبت هذه العضلات تصبح مؤلمة أثناء **التبعيد**.

❖ يمكن أن يلتهب **وتر العضلة فوق الشوكية لوحده**، أما باقي العضلات فنادراً ما تلتهب لوحدها حيث أنها غالباً ما تكون **جزءاً من إصابة الكم الوتري** (متلازمة الكفة المدورة).

تناذر الكم الوتري (متلازمة الكفة المدورة):

☑ تعد **أشيع أسباب الألم الكتفي**، ويحدث في هذه الحالة التهاب في الأوتار أو الأجربة حول المفصل الكتفي العضدي ويترافق مع ألم موضّع يُثار بمقاومة الحركات.

☑ يعد **وتر العضلة فوق الشوكية الأكثر إصابة** كونه يمر بين الأخرم ورأس العضد، وبالتالي يتعرض هذا الوتر أثناء الحركة **للانحشار بينهما**.

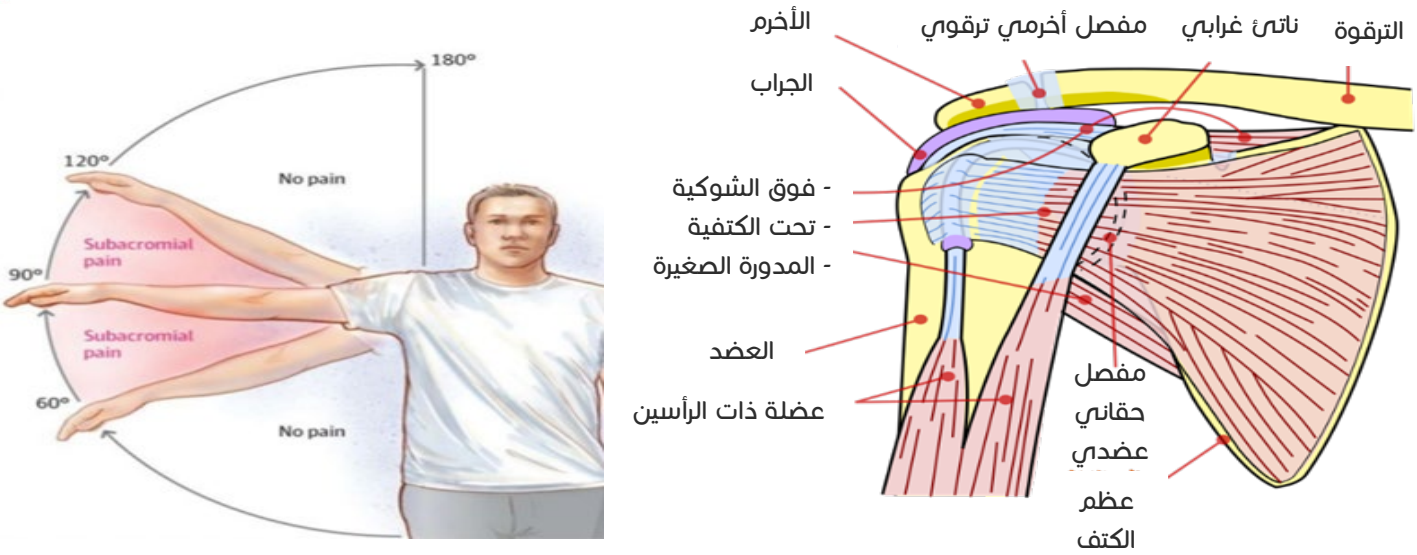
☑ نقوم بتحري علامة الانحشار من خلال رفع الذراع (حركة التبعيد) لـ 60 درجة؛ فيحدث هُنا انحشار وتر العضلة فوق الشوك بين الناتئ الأخرمي ورأس العضد.

← **في الحالة الطبيعية**: تعمل العضلتان تحت الكتفية والمدورة الصغيرة على **شد رأس العضد للأسفل**، مما يسمح لوتر العضلة فوق الشوكية بالحركة ويُخفف الضغط عنه **ويمنعه من الانحشار**.

← **في حال الإصابة**: لا تقوم هاتين العضلتين بعملهما وبالتالي **يتعرض وتر العضلة فوق الشوكية للانحشار**.

← هذا يؤدي لتألّم المريض في الحركة **ابتداءً من الزاوية 60 ويبقى متألماً حتى الزاوية 120**، وبعد هذه الدرجة يبدأ رأس العضد **بالابتعاد** عن وتر العضلة فوق الشوك وبالتالي **يزول الألم بعد الزاوية 120**.

← هذه العلامة، أي الحركة المؤلمة ما بين الزاوية 60 والزاوية 120، تُدعى **القوس المؤلمة**.

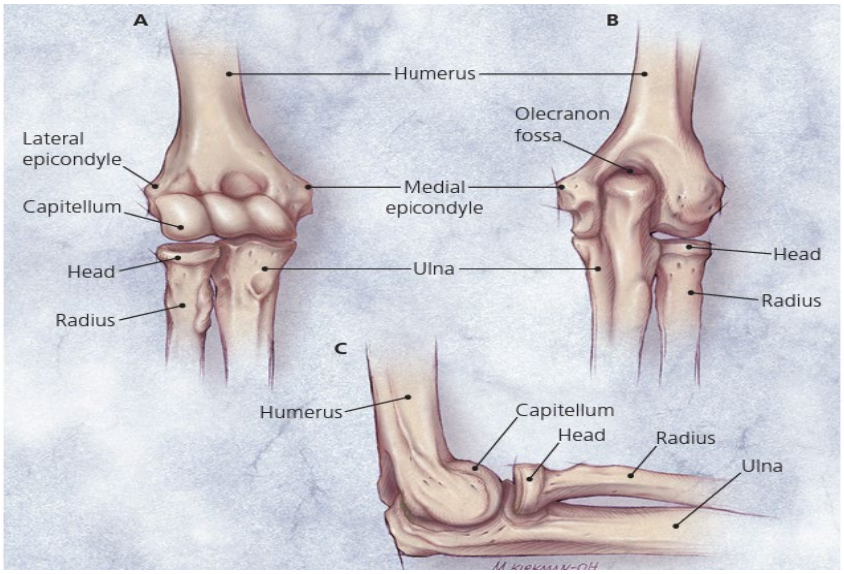


المكونات التشريحية عند مفصل الكتف

القوس المؤلمة

مفصل المِرفَق

- هو المفصل الذي يربط عظم العضد في الذراع بعظمي الكعبرة والزند في الساعد.
- يتكون من ثلاثة مفاصل فرعية ضمن كبسولة واحدة وهي:
  1. المفصل العضدي الزندي.
  2. المفصل العضدي الكعبري.
  3. المفصل الكعبري الزندي الداني.



A: منظر أمامي
B: منظر خلفي
C: منظر وحشي

فحص مفصل المرفق

❖ كما اعتدنا، يكون تسلسل الفحص كالآتي:

التأمل ← الجس ← فحص الحركة

أثناء الفحص يكن المرفق معطوفاً بزاوية 90° كي تكون معالمه واضحة.

أولاً: التأمل Inspection:

الآفات الجلدية	التورمات	التشوهات
• عقد روماتوئيدية. • حطاطات غوترن. • تكلسات. • توفات النقرس. • آفات صدافية. • الأورام الصفراء.	• تورم موضّع: التهاب الجراب أمام الزج. • تورم شامل للمفصل: يترافق مع ألم وتحدد حركة في سياق مرض التهابي.	• الكسور. • الخلوع • الداء الروماتوئيدي.



عقد روماتوئيدية (رثيانية)



توفات نقرسية



آفات صدافية



تكلسات في صلابة الجلد

ثانياً: الجس Palpation:

☑ جس الناتئ الزجي، اللقيمة الإنسية، اللقيمة الوحشية.

☑ في الحالة الطبيعية توجد **وهدات** عند مفصل المِرفق، ولكن في حال وجود انصباب في المفصل تغيب هذه الوهدات.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

☑ جس الحرارة الموضعية:



← في الحالة الطبيعية يكون المفصل **أبرد** من مجاوراته، أما في حالة الالتهاب تزيد التروية الدموية والسايتوكينات الالتهابية **فتزداد حرارة المفصل**.

← يكون جس الحرارة الموضعية بظهر اليد وبالتناوب كما هو موضح بالصورة المجاورة.

ثالثاً: فحص الحركة Movement:

☑ أثناء فحص حركة مفصل المِرفق نقوم بفحص كل من حركات المِرفق بالخاصة وحركات الساعد.

1. حركات المرفق:

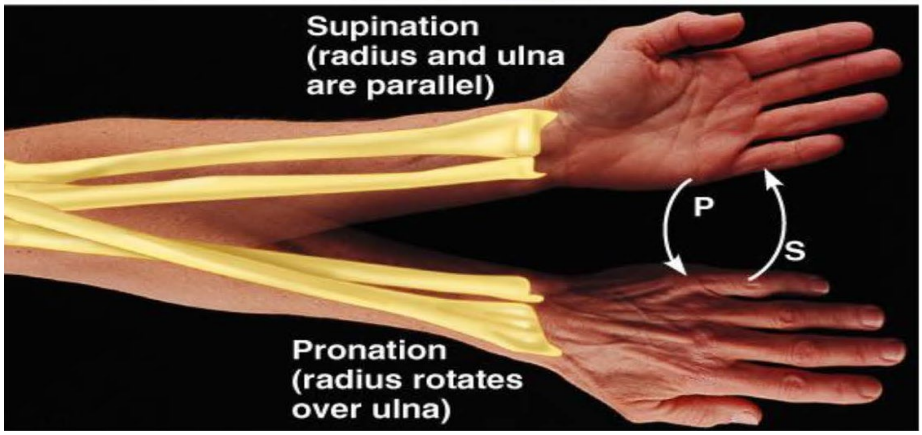
العطف Flexion	البسط Extension

2. حركات الساعد:

الاستلقاء Supination	الكب Pronation

✓ وهي حركات بين الزند والكعبرة.

✓ نلاحظ أنّه خلال حركة الاستلقاء للساعد يكون عظما الزند والكعبرة **متوازيان**، بينما **يتصالبان** في حركة الكبّ.





للتأكد من سلامة المرفق يقوم المريض بالحركات التالية:

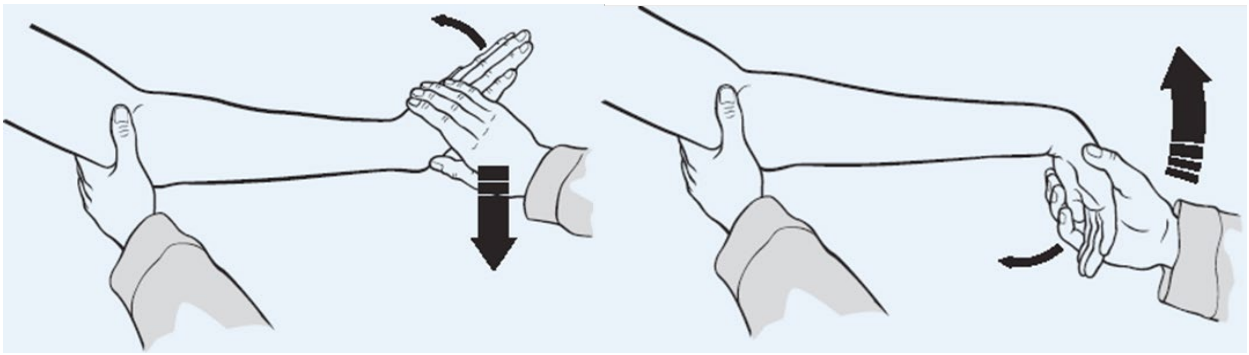
- **بسط** المرفق بوضعيّة **استلقاء** الساعد.
- **عطف** المرفق بوضعيّة **كبّ** الساعد.





بعض إصابات مفصل المرفق

الإصابة	مرفق الغولف Golf Elbow	مرفق التنس Tennis Elbow
موقع الإصابة	التهاب اللقيمة الإنسية Medial Epicondylitis	التهاب اللقيمة الوحشية Lateral Epicondylitis
موقع الألم	▪ اللقيمة الإنسية للعضد. ▪ ينتشر إلى عاطفات الساعد.	▪ اللقيمة الوحشية للعضد. ▪ ينتشر إلى باسطات الساعد.
الفحص السريري والاختبارات	▪ مضض فوق اللقيمة. ▪ يُحرض الألم بمقاومة العطف الفاعل للمعصم.	▪ مضض فوق اللقيمة. ▪ يُحرض الألم بمقاومة البسط الفاعل للمعصم.



فحص مرفق الغولف

فحص مرفق التنس

يكون علاج مرفق الغولف ومرفق التنس دوائياً، وإذا لم تتحسن الحالة يكون العلاج بحقن الستيروئيدات تحت الجلد بجوار الوتر (وليس ضمن الوتر أو فوقه كيلا يتأذى الوتر). *

مُلاحظات سريريّة: RB Clinical

- عندما تكون الإصابة على مستوى الغشاء الزليل أو العظم (مثل نخرة ضمن العظم) فإن حركات المفصل **كلها تكون مؤلمة**، بينما إذا كانت الإصابة وتريّة فقط ستتأذى **الحركة المسؤول عنها الوتر المصاب** (أي حركة فاعلة معيّنة) وتصبح مؤلمة.
- يكون فحص الأوتار بجعل المريض يُجري الحركة المطلوبة (المسؤول عنها هذا الوتر) بوجود مقاومة للحركة من قِبل يد الفاحص، فإذا تألّم المريض نعلم أنّ الوتر مصاب.
- في أغلب الحالات يكون أول عَرَض في التهاب المفاصل الرثياني هو **تحدّد بسط المرفق**.

بعض المفاصل الأُخرى

المفصل الأخرمي الترقوي Acromioclavicular joint

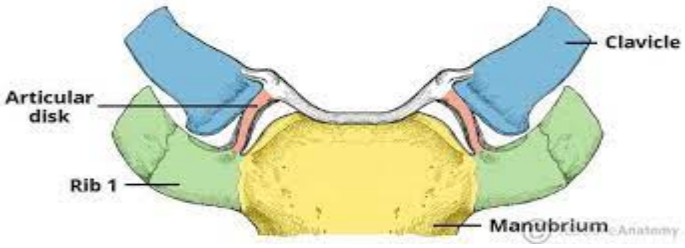
- للناتئ الأخرمي أهمية كبيرة، لأنه نقطة ارتكاز للعديد من أوتار العضلات في منطقة الكتف.
- **المفصل الأخرمي الترقوي:** هو تمفصل الترقوة مع الناحية **الإنسية** للنتوء الأخرمي.
- يكون متضخماً عند كبار السن.
- يصاب كغيره من المفاصل بالآفات الالتهابية والأذيات الميكانيكية.
- تُحدِث إصابته ألماً بتقريب الذراع أمام الصدر فهو يساهم في **حركة التقريب**.





المفصل القصي الترقوي Sternoclavicular joint

- يقع بين النهاية **الإنسية** للترقوة وجانب القص.
- هو مفصل **سطحي** تظهر فيه العلامات الالتهابية بوضوح.
- يمكن أن يصاب بالآفات الالتهابية والميكانيكية **(وهي الأشيع)**، كما أنه يصاب بالإنتان (إنتان المفصل القيحي) لدى مدمني المخدرات وذلك بجراثيم العصيات الزرقاء والزوائف الزنجارية.



المفصل الفكي الصدغي Temporomandibular joint

❖ تُعد إصابة المفصل الفكي الصدغي علامة سوء إنذار لأي مرض. *

أولاً: التأمل Inspection:

☑ نفتش عن **التورم** أمام الأذن عند فتح وإغلاق الفم.

☑ وجود **الاحمرار** يشير إلى التهاب هذا المفصل.

ثانياً: الجس Palpation:

☑ يتم جس المفصل بوضع الإصبع أمام الأذن بينما يقوم المريض بفتح وإغلاق الفم ونتحرى الإيلام.



ثالثاً: فحص الحركة Movement:

☑ بما أنَّ المفصل الصدغي الفكي مفصل لقيمي، فإن له حركات خاصة:

تحريك الفم إلى الأمام والخلف	تحريك الفك إلى الأعلى والأسفل	حركات جانبية

↙ كيف نفحص المفصل الصدغي؟

➤ يجب أن يستطيع الشخص أن يدخل **ثلاثة أصابع متوضعة طولياً** في فمه،[2] وإذا لم يستطع نستنتج وجود مشكلة في المفصل.

- نصل وإيّاكم إلى ختام المحاضرة -

[2] المريض يُدخل أصابع هو في فمه، وليس أصابع الطبيب.